

Insomnio

Guía Psicoeducativa

Lic. Agustina Rey

Psicología Clínica Online

Terapia Cognitivo Conductual · Mindfulness · ACT

quieroterapia.com.ar

01. ¿Qué es el insomnio?

El insomnio es la dificultad persistente para iniciar el sueño, mantenerlo o lograr un sueño reparador, a pesar de tener las condiciones adecuadas para dormir. Se considera clínicamente significativo cuando ocurre al menos tres noches por semana durante un período de al menos tres meses y genera malestar o deterioro del funcionamiento diurno.

Tipo	Descripción
Insomnio de inicio	Dificultad para conciliar el sueño al acostarse (más de 20-30 min).
Insomnio de mantenimiento	Despertares frecuentes o prolongados durante la noche, con dificultad para volver a dormir.
Despertar precoz	Despertar espontáneo antes de lo deseado, sin poder volver a dormir.
Sueño no reparador	Dormir las horas necesarias pero levantarse con sensación de no haber descansado.

02. El ciclo del insomnio

El insomnio crónico se mantiene a través de un ciclo que va más allá de la causa original:

- Dificultad para dormir (puede tener múltiples causas iniciales)
- Activación fisiológica y cognitiva al intentar dormir: pensamientos, tensión, hipervigilancia
- Esfuerzo por controlar el sueño: "Tengo que dormirme ya", "Si no duermo, mañana no voy a poder"
- El esfuerzo genera mayor activación, lo opuesto al estado necesario para dormir
- Conductas compensatorias: irse a la cama antes, quedarse más tiempo en cama, siestas
- Las conductas compensatorias fragilizan el sueño nocturno

Clave clínica: El insomnio crónico es frecuentemente mantenido por las estrategias que la persona usa para tratar de resolverlo. La TCC para el insomnio (TCC-I) es la intervención de primera línea.

03. Factores que mantienen el insomnio

Factor	Descripción
Hiperactivación cognitiva	Pensamientos acelerados, preocupaciones, rumiación al acostarse o al despertarse de noche.
Hiperactivación fisiológica	Tono muscular elevado, temperatura corporal alta, activación del sistema nervioso simpático.
Conductas de seguridad disfuncionales	Irse a la cama muy temprano, quedarse más tiempo en cama, siestas largas.
Creencias sobre el sueño	"Necesito 8 horas exactas", "Una noche mala arruina todo el día siguiente".
Condicionamiento negativo	La cama se asocia con activación y frustración en lugar de sueño.
Uso de pantallas en la	Luz azul, estimulación cognitiva y emocional incompatibles con

Factor	Descripción
cama	la transición al sueño.

04. Higiene del sueño: fundamentos

Conductas que favorecen el sueño:

- Horario regular: acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana
- Reservar la cama exclusivamente para dormir (y sexo): no leer, trabajar, ver pantallas en la cama
- Rutina de relajación previa: 30-60 min de actividades calmas antes de acostarse
- Ambiente adecuado: oscuridad, temperatura fresca (18-20°C), silencio o ruido blanco
- Evitar cafeína después del mediodía y alcohol como inductor del sueño
- Actividad física regular, preferentemente no en las últimas 3 horas antes de dormir

Conductas a evitar:

- Siestas largas (más de 20-30 min) o tardías (después de las 15 h)
- Mirar el reloj durante la noche
- Quedarse más tiempo en la cama para "recuperar" el sueño perdido
- Usar el teléfono o pantallas en la cama o ante despertares nocturnos

05. Restricción del sueño

La restricción del sueño es la técnica central de la TCC-I. Consiste en reducir el tiempo en cama al tiempo real de sueño, generando presión de sueño que consolida el ciclo. Puede producir somnolencia transitoria pero es muy efectiva:

- Determinar el tiempo promedio real de sueño (ej: 5 horas)
- Fijar una ventana de sueño equivalente: acostarse a las 24 h y levantarse a las 5 h
- Levantarse a la misma hora todos los días independientemente de cómo se durmió
- No irse a la cama antes de tener somnolencia real
- Ampliar la ventana de 15-30 min por semana a medida que mejora la eficiencia del sueño

Nota clínica: La restricción del sueño no debe aplicarse en personas con trastorno bipolar, epilepsia, apnea del sueño no tratada o en contextos de alta demanda de seguridad (conducción, maquinaria).

06. Trabajo cognitivo

Creencias disfuncionales frecuentes sobre el sueño:

- "Necesito exactamente 8 horas para funcionar" → Las necesidades de sueño varían. La mayoría funciona bien con 6-8 h.
- "Si no duermo bien, mañana todo va a salir mal" → La catastrofización sobre las consecuencias amplifica la activación.
- "Si no me duermo en X minutos, no voy a dormir en toda la noche" → El sueño es cíclico; siempre hay oportunidades de volver a dormirse.
- "Tengo que obligarme a dormir" → El sueño no responde al esfuerzo voluntario; solo ocurre cuando se dan las condiciones.